

# RES. QX. PATOLOGÍA AGUDA DE COLUMNA

| Nº | PROYECTOS                           | HOSPITAL A CARGO | ALCANCE                                              | PRESTACIONES                                                                               | CRITERIOS DE LLAMADO                                                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVACIÓN DE LLAMADA                                                                                    | FIRMA CERTIFICADOS                      |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4  | RES. QX. PATOLOGÍA AGUDA DE COLUMNA | CASR             | Todo paciente mayor de 15 años de la red sur oriente | 1) Discectomía<br>2) Laminectomía descompresiva<br>3) Fijación de columna<br>4) Artrodesis | Traumatismo raquímedular (TRM) con compromiso neurológico (paraplejía, tetraplejía observada)<br>Compresión medular<br>Mielitis transversa por infección o abscesos peridurales con compromiso neurológico<br>Inestabilidad de columna por trauma sin compromiso neurológico | *Traumatólogo de turno de UEH adultos del CASR.<br>*Médico jefe de turno de Cirugía UEH Adultos del CASR | Jefe Unidad Emergencia Adultos del CASR |

## Referencia o derivación:

- ❖ El médico a cargo del paciente debe derivar el paciente a la UEH adultos del CASR
- ❖ El traumatólogo de turno de la UEH Adultos del CASR o en su defecto cirujano de turno, definirá pertinencia según criterios de llamado (punto 9.4). De ser pertinente llamará al especialista de columna en turno, el cual definirá finalmente si cumple criterio de intervención quirúrgica de urgencia. De no ser pertinente o descartarse la indicación de intervención de urgencia, en el caso de pacientes de HPH y HLF, el paciente será devuelto a Hospital Base.
- ❖ El especialista de llamada acudirá a resolver quirúrgicamente dicha urgencia y definirá si paciente debe permanecer en CASR o retornar a establecimiento de origen post procedimiento.
- ❖ La derivación es sólo desde Hospitales al CASR y de manera coordinada, en el caso de los Servicios de Urgencias de APS, deben derivar a su Hospital Base correspondiente.



**Contrarreferencia:**

- ❖ Posterior al procedimiento y según condición clínica, los pacientes se trasladarán a cama de CASR o se dará la indicación de retorno a su Hospital Base.
- ❖ El retorno a Hospital Base debe realizarse de manera coordinada entre los equipos de Gestión de Camas correspondientes.
- ❖ Todo paciente que retorna a Hospital Base debe contar con el pase del especialista del equipo de columna del CASR.
- ❖ El retorno a hospital base debe asegurarse a una cama hospitalaria, según requerimientos del paciente y disponibilidad. Es importante que el Hospital Base asegure una cama para recepción del paciente desde CASR, gestión que debe iniciar Hospital Base desde el momento que deriva el paciente al CASR.
- ❖ La entrega de paciente será realizada a través de los equipos de Gestión de Camas con Informes médicos respectivos.
- ❖ Es responsabilidad del hospital de destino (Hospital Base) coordinar ambulancia para el traslado de manera inmediata. De igual forma CASR puede gestionar ambulancia, si su situación hospitalaria se lo permite.



# En resumen,

- El médico a cargo del paciente debe derivar el paciente a la UEH adultos del HDSR, informando previamente del traslado.
- El médico a cargo del paciente en el hospital de origen debe informar el traslado a los siguientes anexos: En primera instancia el llamado es a la Estación de enfermería de UEH Adultos del HDSR.

| TELÉFONOS UEH ADULTOS CASR 2025 |           |                  |           |
|---------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Lugar                           | Teléfono  | Anexo Red MINSAL | Celular   |
| Estación Enfermería             | 225762662 | 262662           |           |
|                                 | 225762363 | 262363           |           |
| Reanimador UEH Adultos          | 225762353 | 262353           |           |
| Médico Coord. UEH Adultos       |           |                  |           |
|                                 |           |                  | 999980214 |

- El traumatólogo de turno de la UEH Adultos del HDSR o en su defecto cirujano de turno, definirá pertinencia según criterios de urgencia.
- De ser pertinente, el traumatólogo de turno de las UEH adultos del HDSR o en su defecto el cirujano de turno se contactará con el especialista de columna, el cual definirá finalmente si cumple criterio de intervención quirúrgica de urgencia.
- Si se requiere de RNM para definir las acciones a seguir por parte del especialista de columna, el paciente esperará en HDSR la realización del examen hasta contar con la respuesta del especialista.
- De no ser pertinente o descartarse la indicación de intervención de urgencia, este usuario será devuelto a su Hospital Base de manera inmediata. Es responsabilidad de HPH buscar la cama o lugar donde se recepcionará el usuario.
- **Es fundamental que cada vez que se envíe un paciente a HDSR, exista comunicación vía correo electrónico y teléfono entre los equipos de Gestión de Camas de los establecimientos involucrados, es necesario este paso para las gestiones de derivación, asignación de cama si corresponde o retorno del usuario a su hospital base.**

**Para patologías de columnas que no tienen criterio de urgencia, la derivación es vía Gestión de Camas.**